

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 13:00:13

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Juan Luis Garrido Quiroz
Edad : 68a 4m 19d
Dirección : Pje Captina 0832 Chayaventos

Rut : 6.884.227-1
Fecha Nacto: 07/12/1953
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A061549
Sexo : Masculino
Teléfono : 966811251

N° Epicrisis
302720

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 24/02/2022 12:04

Días Estadía: 61

Unidad de Egreso : Medicina Básica (4to Piso)

Fecha Egreso : 26/04/2022 15:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

COVID19

Comorbilidades

Hipertensión Arterial; Diabetes Mellitus 2; EPOC; Obesidad;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Traqueostomía (Proc. Aut.) - 16/03/2022 14:50 - Jorge Eliser Cornejo Figueroa

Epidemiología

- Infec: Neumonía asociada a ventilación mecánica - Germen: Sams, E.Cloacae, K. Oxytoca
- Infec: Infección tracto urinario asociada a Fonda Foley - Germen: Kpn Ms, E. Faecalis Ms

Resumen Clínico

Fecha de ingreso CASR: 24/02/2022
Fecha de ingreso UCI: 25/02/2022
Fecha de ingreso UTIM: 08/04/2022
Fecha de ingreso Sala Básica: 20/04/2022

Antecedentes:

- Médicos: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) por tabaco, obesidad grado 3. Neumonía grave 2008 en UCI hospital de carabineros, con paro cardiorrespiratorio recuperado.
- Quirúrgicos: Orquiepididimitis
- Alergias: (-)
- Fármacos: Enalapril 10 mg BID, amlodipino, atorvastatina, metformina 850 mg TID, Brexotide 500/50 mcg BID, Br. Ipratropio 40 mcg BID
- Hábitos: Tabaco: IPA xx suspendido hace 12 años, alcohol: No, drogas: No
- Hospitalizaciones recientes: (-)
- Inmunizaciones: COVID 3 dosis, FLU 2021, Neumo 23 2019
- Social: Autovalente, vive con esposa y nieta en Puente Alto. Carabinero retirado. Trabaja como guardia de seguridad.

Motivo de consulta: disnea

Historia de ingreso:

Paciente con los antecedentes descritos, consulta por cuadro de 4 días de evolución de aumento de la disnea basal desde mMRC 1 a 3, sin sibilancias, aumento de la tos ni cambio en la expectoración. Niega también síntomas gastrointestinales y urinarios, ortopnea, disnea paroxística nocturna, nicturia y edema de extremidades inferiores. Las últimas 48 horas evoluciona con sensación febril no cuantificada y dificultad respiratoria franca, por lo que consulta en la atención primaria. A la evaluación se constata insuficiencia respiratoria con saturación 52% ambiental y taquipneico hasta 35 rpm. Recibe aporte de oxígeno hasta 15 L/min por mascarilla de no recirculación, se realiza test de antígeno para SARS CoV-2 (+) y es derivado al servicio de urgencias del CASR.

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 13:00

Página 1 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Ingresa en malas condiciones generales con compromiso respiratorio persistente pese a medidas instauradas, con tendencia a la taquicardia 95 lpm, hipertenso leve 136/100 mmHg, subfebril 37.2°C, saturando 81% pese a MRNC 15 L/min, taquipneico 35 rpm. Al examen sin uso de musculatura accesoria, pero con crépitos difusos.

Se evalúa con AngioTAC que descarta tromboembolismo pulmonar agudo, sin embargo con presencia de neumopatía multilobar compatible con COVID-19. En este contexto se inicia manejo con cánula nasal de alto flujo hasta parámetros altos, aún refractario, con saturaciones inferiores a 85% persistentes. Por antecedente de EPOC se intenta manejo con ventilación mecánica no invasiva, con buena respuesta inicial, pero con progresión de la falla respiratoria, requiriendo intubación e inicio de ventilación mecánica invasiva. Posterior a eso se transfiere al paciente a unidad de cuidados intensivos para su manejo.

Exámenes de ingreso:

24/02/22: Hb 12.7 GB 11.700 PLQ 286K ELP 139/4.66/106 GSV pH 7.36 pCO2 42.6 HCO3 23.4 BE -2.1 INR 1.12 TTPK 25.2 crea 0.97 BUN 19.2 Gluc 338 LDH 387 PCR 185.9

Microbiología de ingreso:

24/02/22: PCR SARS COV 2 (+)

Diagnósticos de ingreso:

1. Insuficiencia respiratoria aguda grave - Neumonía grave por SARS CoV-2
2. EPOC GOLD desconocido.
3. Diabetes mellitus tipo 2
4. Hipertensión arterial
5. Obesidad G3

Evolución en hospitalización:

1. Hemodinamia: ingresa estable, con requerimientos de vasoactivos en relación a sedoanalgesia profunda, con suspensión el 28/02. En relación a quiebre infeccioso el 05/03 con nuevos requerimientos de dosis intermedias de noradrenalina. En contexto de nuevo hit infeccioso el 12/03 recibe Milrinona por ecoscopía con hipomotilidad, suspendida por arritmias e inestabilidad hemodinámica. Con la mejoría del cuadro séptico logra la suspensión de vasoactivos de forma definitiva. El día 23/03 en relación a anemia sin exteriorización de sangrado se transfunde 1 UGR. Evoluciona con hipertensión arterial leve se reinician vasodilatadores orales en dosis bajas.

2. Ventilatorio: PaFI de ingreso a UPC en 109, con requerimientos de pronó 7 días y bloqueo neuromuscular (BNM) por 9 días (hasta el 04/03) con PaFI mayor a 200 sostenida. Sin embargo el día 12/03 presenta inestabilidad hemodinámica con caídas progresivas de la PaFI con lo que se sospecha tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) y se decide en este momento inicio de anticoagulación empírica, además de nuevo ciclo de BNM. Se confirma TEP subsegmentario bilateral en angioTAC el 13/03. Logra suspensión del BNM tras inicio de la anticoagulación. Por ventilación prolongada se realiza traqueostomía quirúrgica el día 16/03 sin incidentes. Disminución del soporte progresivo, pasando a CPAP y luego filtro. El 13/04 se cambió TQT a menor calibre, tolerando más de 48 horas con oclusión, por lo que se decanula el 16/04 sin incidentes. Evoluciona posteriormente el 21/04 con clínica obstructiva y aumento de los requerimientos de oxígeno, recibiendo tratamiento para exacerbación de EPOC con broncodilatación y corticoides sistémicos por 5 días, con la consecuente mejoría y cese de los requerimientos de oxígeno el 25/04 AM. Respecto a la anticoagulación, se ajusta por peso a Enoxaparina 120 mg BID, y se decide uso de antagonistas de Vitamina K por IMC marcadamente elevado. Traslapa a realizar en hospitalización domiciliaria.

3. Infeccioso: a su ingreso COVID (+) se determina uso de protocolo RECOVERY además de uso de Ceftriaxona en contexto de posible descompensación de EPOC, con pronta suspensión. Buena evolución clínica y de laboratorio inicial, en relación a deterioro clínico, leucocitosis y ascenso de parámetros inflamatorios se pancultiva el 05/03 CAET (+) para SAMS, iniciándose Imipenem + Vancomicina, con nuevos cultivos el 09/03 con 1 hemocultivo (+) tardío para *Corynebacterium* (interpretado como contaminación) y UC (+) *E. faecalis*. Se conversa con infectología y se decide BIC de cloxacilina (considerando cobertura para *E. faecalis* resuelta con Vancomicina previa), que recibe hasta el 17/03. Presenta nuevo quiebre clínico con presencia de *K. oxytoca* en CAET 15/03 y UC (+) KPN MS, rotando de Cloxacilina a Ciprofloxacino EV, completando 10 días. Nuevo hit el 04/04, con CAET con *E. cloacae* y cultivo de punta de catéter (+) para *S. epidermidis*, recibiendo Imipenem + Vancomicina por 10 días. En UTIM, dado 3 CAET consecutivos para SAMS, se decide rotar a cefazolina para completar por 7 días en plan de erradicar SAMS, con descenso de los parámetros inflamatorios y evolucionando afebril. En relación a episodio de retención aguda de orina del 20/04 con orina completa inflamatoria, recibe Ampicilina + Amikacina por peso ajustado, con UC (-)

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 13:00:13

Página 3 de 5

completa 48 horas de ampicilina y 5 días de Amikacina, con disminución de los parámetros inflamatorios. En relación a reposo prolongado y humedad con candidiasis del pañal, con excelente respuesta a Clotrimazol/Zinc.

4. Urológico: desde el ingreso con función renal estable. Presenta falla renal post renal asociada a globo vesical el 28/02 secundario a la presencia sonda foley disfuncional, con mejoría tras el cambio. Presenta retención aguda de orina al intento de retiro de sonda foley el 20/04, estudiado con ecografía pélvica que informa acentuado aumento de volumen prostático, pero sin vejiga de lucha. En vista de lo anterior, se retira sonda foley, pero evoluciona con residuos postmictoriales elevados, por lo que se decide reinstalación de sonda y evaluación por urología ambulatoria. APE tomado previo al alta, pendiente.

5. Medio interno: durante la hospitalización sin mayor conflicto.

6. Metabólico: paciente con diabetes tipo 2 no insulino-requiriente y con obesidad grado 3 (IMC 43.9). Recibe nutrición enteral por sonda nasogástrica de forma casi ininterrumpida. Tras autorización por fonoaudiología reinicia régimen oral. Al ingreso presenta necesidad de BIC de Insulina con regular control. Se ajusta a esquema basal + hipoglucemiantes orales.

7. Rehabilitación: evoluciona en relación a larga estadía en UCI, gravedad del cuadro, ventilación mecánica prolongada y uso de bloqueo neuromuscular evoluciona como paciente crítico crónico. Recibe rehabilitación intensiva multimodal. Lesión por presión glútea grado 2 que mejora con curaciones por enfermería y movilización frecuente.

- Delirium: decalaje progresivo de antipsicóticos y benzodiacepinas hasta su suspensión.

- Deglución: tras terapia de rehabilitación logra fonación adecuada y alimentación con régimen de consistencia común.

- Traqueostomía: se decanula el 16/04 tras oclusión bien tolerada. Sin conflicto posterior.

- Motor: evoluciona con miopatía proximal en contexto de miopatía del paciente crítico. Con kinesioterapia intensiva logra bípedo con máxima asistencia, buen control de tronco y sedente borde cama por 30 minutos, aún siendo necesaria asistencia máxima para traslado de cama a sillón. Se decide alta con hospitalización domiciliar para kinesioterapia de rehabilitación.

16/03/22 Instalación traqueostomía: Se coloca cánula de traqueostomía Portex N° 8. Cirugía sin incidentes

Imágenes:

25/04/22 Ecografía pélvica masculina: Vejiga normal. Volumen premiccional: 920 cc. Acentuado aumento de tamaño de la glándula prostática, 6,6 x 7,3 x 5,1 cm = volumen aprox 130 cc.

12/04/22 TAC de tórax: Disminución en extensión de los focos de condensación bilaterales respecto al estudio previo. Disminución de leve derrame pleural izquierdo y resolución del derrame pleural derecho. Atelectasia casi completa del LII.

13/03/22 AngioTAC de tórax: Signos de tromboembolismo pulmonar agudo en ramas subsegmentarias bilaterales. No hay sobrecarga de cavidades derechas. Aumento de calibre del tronco de arteria pulmonar, signo sugerente de hipertensión pulmonar. Opacidades pulmonares bilaterales en contexto de Covid-19 conocida, sin variaciones. Escaso derrame pleural bilateral, sin cambios.

Diagnósticos de egreso:

Síndrome de distress respiratorio grave secundario a Neumonía por SARS CoV-2

- Tromboembolismo pulmonar subsegmentario bilateral provocado 13/03

- Ventilación mecánica invasiva prolongada, 3 ciclos de bloqueo neuromuscular

- Traqueostomía quirúrgica 16/03 al 16/04

Paciente crítico crónico en rehabilitación

- Miopatía del paciente crítico.

- Disfagia leve FILS 8 resuelta

- Lesión por presión glútea G2 resuelta

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada resuelta

Candidiasis del pañal en tratamiento

Verruga extremidad superior izquierda

Hiperplasia prostática benigna

Neumonía por SAMS 05/03

Infección del tracto urinario por E. faecalis MS 07/03

Traqueobronquitis por K. oxytoca MS + SAMS 15/03

Infección del tracto urinario por KPN MS 17/03

Cultivo punta catéter (+) por S. epidermidis MR S Cotrimoxazol, Vancomicina, Rifampicina 30/03

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 13:00

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 13:00:13

Página 4 de 5

Neumonía por SAMS + E. cloacae S Amikacina, Meropenem, Imipenem 30/03
Neumonía por SAMS 05/04 y 09/04
Infección del tracto urinario - sin microbiología 21/04
Colonización por C. albicans.
Diabetes mellitus tipo 2.
Obesidad grado 3.

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida En La Comunidad (Nac) -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En buenas condiciones, M4- proximal en extremidades superiores e inferiores, levemente hipertenso, sin requerimientos de oxígeno en 24 horas, afebril, con lesión por presión glútea derecha grado 2 de 1x1 cm.

Plan Post Alta

Se presenta a hospitalización domiciliaria para:

1. rehabilitación kinesiológica respiratoria y motora. Uso de Triflo.
2. Educación en uso de insulina, auto monitoreo de glicemias y manejo de hipoglicemia
3. Ajuste de esquema de insulina según requerimientos.
4. Traslape a Acenocumarol, recibiendo Enoxaparina 120 mg cada 12 horas subcutáneo
5. Cuidados de la sonda foley

Régimen común, 200 g de HdeC, hiposódico, bien sentado 90°.

Uso de incentivador volumétrico (Triflo).

Hemoglucotest cada 8 horas precomidas

Uso de insulina 22 unidades AM y 8 unidades PM

Clotrimazol crema aplicar en zona inguinal cada 12 horas, hasta el lunes 2 de mayo inclusive.

Brexotide 2 puff cada 12 horas con aerocámara

Berodual 2 puff cada 6 horas con aerocámara

Bromuro de Ipratropio 2 puff SOS con aerocámara

Enoxaparina 120 mg cada 12 horas subcutáneo

Losartán 50 mg, 1/2 (medio) comprimido al día, vía oral

Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos SOS en caso de dolor máximo cada 8 horas, vía oral

Metformina 850 mg, 1 comprimido cada 8 horas con las comidas, vía oral.

Polietilenglicol 3350, diluir 15 gramos en 250 ml de agua, usar cada 8 horas, disminuir si logra 2 deposiciones diarias, vía oral.

Tamsulosina 0.4 mg, 1 comprimido en la noche, vía oral, hasta control con Urología.

Controles:

Policínico de TACO, meta INR 2-3.

Broncopulmonar CDT, retomar controles para ajuste de terapia y seguimiento de EPOC. Anticoagulación por TEP 6 meses.

Urología CDT, hiperplasia prostática benigna, residuo post miccional 300 ml. Egresada con sonda foley, APE pendiente.

APS, control de hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad grado 3.

APS, manejo de verruga brazo izquierdo

En caso de sudoración, mareos, palpitaciones o compromiso de conciencia tomar hemoglucotest.

Si está menor a 70 mg/dL administrar 1 vaso de bebida NO light (bebida normal), 1 vaso de jugo NO light o 1 vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar, y control de hemoglucotest en 15 minutos.

Si nuevamente es menor a 70 mg/dL, repetir lo anterior, y control en 15 minutos.

Si nuevamente es menor a 70 mg/dL, repetir lo anterior, y traer al servicio de urgencia.

Si no es capaz de tomar los líquidos, traer de inmediato al servicio de urgencias.

Consultar en el servicio de urgencias en caso de dificultad respiratoria, fiebre, sangrados, compromiso de conciencia, hipoglicemia que no responde a manejo inicial.

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 13:00

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

S/F - CDT - Urología - hiperplasia prostática benigna, residuo post miccional 300 ml. Egresada con s.foley, APE pendiente.

S/F - APS - - manejo de verruga brazo izquierdo

S/F - APS - - control de hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad grado 3.

S/F - CDT - Broncopulmonar adultos - retomar controles para ajuste de terapia y seguimiento de EPOC. Anticoagulación por TEP 6 meses.

S/F - CDT - PoliTACO - meta INR 2-3

INTERNO

Jorge Andrés López Ruiz-Esquide

Becado/Residente

Alberto Saffatis Feige

Médico Tratante (Staff)